Algoritmo CIF — Cadera

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Cadera. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 6cd94a01

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

1 ¿El dolor podría ser referido desde la columna lumbar o la articulación sacroilíaca?

SÍ
SACROILÍACA: señala con el dedo el dolor inferomedial a la EIPS (no solo en la línea media ni por encima de L5) y 3 o más de 5 tests de provocación positivos
→ 10 Dolor Articular Sacroilíaco

SÍ
LUMBAR: el dolor cambia con movimientos repetidos de la espalda, o la elevación de la pierna recta o el slump reproducen su dolor
→ sin hipótesis

NO
Origen coxofemoral: la cojera (unas 7 veces) y la rotación interna limitada (unas 14 veces) orientan más a la cadera que a la columna
→ sin hipótesis

todas

1b ¿Hay un evento desencadenante concreto y reciente (chut, sprint, cambio de dirección, estiramiento)?

SÍ
LESIÓN AGUDA: palpar primero; luego resistencia y estiramiento
→ 11 Lesión Aguda de Ingle

NO
Sin evento desencadenante concreto
→ sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 2 ↓

↓ Paso 2: viene del paso 1b

2 ¿El perfil es degenerativo (edad ≥45 años, rigidez matutina breve)?

SÍ
Edad ≥45 años, rigidez matutina <1 hora, rotación interna <24°
→ 1 Artrosis de Cadera

NO
Paciente joven/activo con síntomas mecánicos
→ sin hipótesis

todas

3 ¿Sospecha de origen intraarticular: dolor inguinal ligado al movimiento con FADDIR o flexión-RI positivos? Estos tests descartan; positivos no confirman.

SÍ
Compatible con pinzamiento femoroacetabular (SIFA), sin confirmar: seguir con Thomas
→ 2 Síndrome de Pinzamiento Femoroacetabular (SIFA)
→ desvío 3b

SÍ, con chasquido doloroso, bloqueo o fallo
Posible desgarro labral
→ 2 Síndrome de Pinzamiento Femoroacetabular (SIFA)
→ 3 Desgarro del Labrum Acetabular
→ desvío 3b

NO
FADDIR y flexión-RI negativos: origen intraarticular improbable
→ sin hipótesis

NO EXPLORADO
FADDIR y flexión-RI no realizados (contraindicados o no tolerados): origen intraarticular sin valorar
→ sin hipótesis

NO / NO EXPLORADO → sigue en el paso 4, en la página siguiente →

Desvío desde el paso 3 si «SÍ» o «SÍ, con chasquido doloroso, bloqueo o fallo»

Sí / Sí, con chasquido doloroso, bloqueo o fallo

3b ¿Thomas positivo con historia compatible (signo de la «C», síntomas mecánicos)? Identificar la entidad; pueden coexistir.

INESTABILIDAD / LIGAMENTO REDONDO →
12 Ligamento Redondo e Inestabilidad

CONDROPATÍA → 13 Condropatía de Cadera

ARTROSIS → 1 Artrosis de Cadera

FAIS / LABRUM → sin hipótesis

NO CONCLUYENTE → sin hipótesis

→ sigue en el paso 4

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de cadera inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.

↓ Paso 4: viene del paso 3 o del 3b

4 ¿El dolor se localiza en la CARA EXTERNA de la cadera (trocánter mayor)?

SÍ Sensibilidad en trocánter mayor y dolor en apoyo monopodal <30s	→	4 Síndrome de Dolor Trocantérico Mayor (Tendinopatía Glútea)
SÍ Con marcha de Trendelenburg o debilidad medida en abductores	→	5 Debilidad de Abductores de Cadera
SÍ Calidad deficiente en sentadilla monopodal o step-down	→	6 Disfunción de Control Neuromuscular de Cadera
NO Sin dolor lateral	→	sin hipótesis

todas →

5 ¿El dolor se localiza en el GLÚTEO o zona isquiática?

Dolor profundo en glúteo que empeora al sentarse (ciática) posible Síndrome Piriforme	→	7 Síndrome Glúteo Profundo (Síndrome Piriforme)
Dolor que empeora con zancada larga al caminar posible Pinzamiento Isquiofemoral	→	8 Pinzamiento Isquiofemoral
Sensibilidad sobre tuberosidad isquiática posible Tendinopatía Proximal Isquiotibiales	→	9 Tendinopatía Proximal de Isquiotibiales
Sin localización clara posterior	→	sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 6 ↓

↓ Paso 6: viene del paso 5

6 ¿Qué reproduce su dolor conocido en la INGLE? Palpar primero y con precisión: las estructuras se solapan.

ADUCTOR Palpación dolorosa de aductores + squeeze doloroso	→	16 Dolor Inguinal Relacionado con el Aductor
PSOAS ILÍACO Palpación dolorosa supra o infrainguinal	→	17 Dolor Inguinal Relacionado con el Psoas Ilíaco
INGUINAL Palpación dolorosa del canal sin hernia palpable (de pie y con tos)	→	18 Dolor Inguinal Relacionado con el Canal Inguinal
PÚBICO Palpación dolorosa de la sínfisis y el hueso adyacente	→	19 Dolor Inguinal Relacionado con el Pubis
NINGUNO Sin dolor inguinal o nada lo reproduce	→	sin hipótesis

todas →

7 ¿Hay un patrón neuropático, o nada encaja y el dolor es extenso?

MERALGIA Tinel bajo la EIAS, parestesias anterolaterales del muslo	→	14 Neuropatías de Cadera e Ingle
OBTURADOR Dolor en ingle y muslo medial con el ejercicio	→	14 Neuropatías de Cadera e Ingle
ILIOINGUINAL, ILIOHIPOGÁSTRICO O GENITOFEMORAL Arch and twist de pie	→	14 Neuropatías de Cadera e Ingle
PUDENDO Dolor perineal al sentarse o en bici, sin déficit sensitivo objetivo	→	14 Neuropatías de Cadera e Ingle
SENSIBILIZACIÓN CENTRAL Nada encaja o dolor extenso (revisar banderas rojas)	→	15 Sensibilización Central
NINGUNO Sin patrón neuropático ni dolor extenso	→	sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de cadera inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.